

PÉDIATRIE

DR.KHERBA_N

PÉDIATRIE

Allergie aux protéines de lait de vache APLV

Anorexie

Arthrite juvénile idiopathique

Balanite

Bronchiolite

Déshydratation

Détresse respiratoire

Énurésie

Fièvre

Gaz chez les bébés

Hydrocèle

Hypoglycémie

Ictère néonatale

Kawasaki

Laryngite

PNA

Poussée dentaire

Ration de base

Retard de croissance

Rougeole

Rubéole

Sortie de nouveau né

Supplémentation en vitamine D

Syndrome de Tourniquet

Syndrome mains pieds bouche

Viroses

Allergie aux protéines de lait de vache APLV

● Clinique :

RGO, vomissements, diarrhées, ballonnements, douleur abdominale, œdème inexpliqué, terrain atopique (visage rouge les joues surtout..)

■ Biologie :

■ Hypereosinophilie

■ Anémie

■ IgE total élevé

■ Hypoalbuminémie

■ Prick test+++

✓ Lait sans PLV :

■ Pepti junior

■ Aptamil

■ Novalac riz

- Si les signes disparaissent on confirme le diagnostic

Anorexie

- Perte de l'appétit

- Appétito sirop 1flc :

<3ans : 1cac 3/j

3_6ans : 2cac 3/j

>6ans : 3cac 3/j

Ou Appetitina >5mois: 1cac 2/j >5ans: 2cac 2/j

Ou Grossivit sirop

Vitatine sirop

Pediakid appétit sirop

Appétit kid sirop

Arthrite juvénile idiopathique

● Clinique :

- Arthrite inflammatoire articulaire
 - Douleur inflammatoire nocturne ↘
mouvements, pas calmée par le repos
 - Tuméfaction diffus, rougeur, chaleur
- <16ans, durée >6semaines, sans cause
- AEG, fièvre>15j, ADP, hépato splénomégalie
 - Éruption cutanée : érythème localisé fugace, maculopapuleux..

■ Bilan :

- FNS : Syndrome inflammatoire

Hyperleucocytose à PNN, Hyperplaquettose,
Anémie inflammatoire

■ Syndrome d'activation macrophagique :

■ Thrombopénie/Leucopénie

■ VS/CRP ↗

■ Fibrinogène

■ Hypoprotidémie

■ Transaminases ↗

■ Ferritinémie ↗

■ ASLO ↗

■ TG ↗

■ Na ↓

■ FR

■ Rx :

■ Déminéralisation épiphysaire

■ Pincement diffus de l'interligne

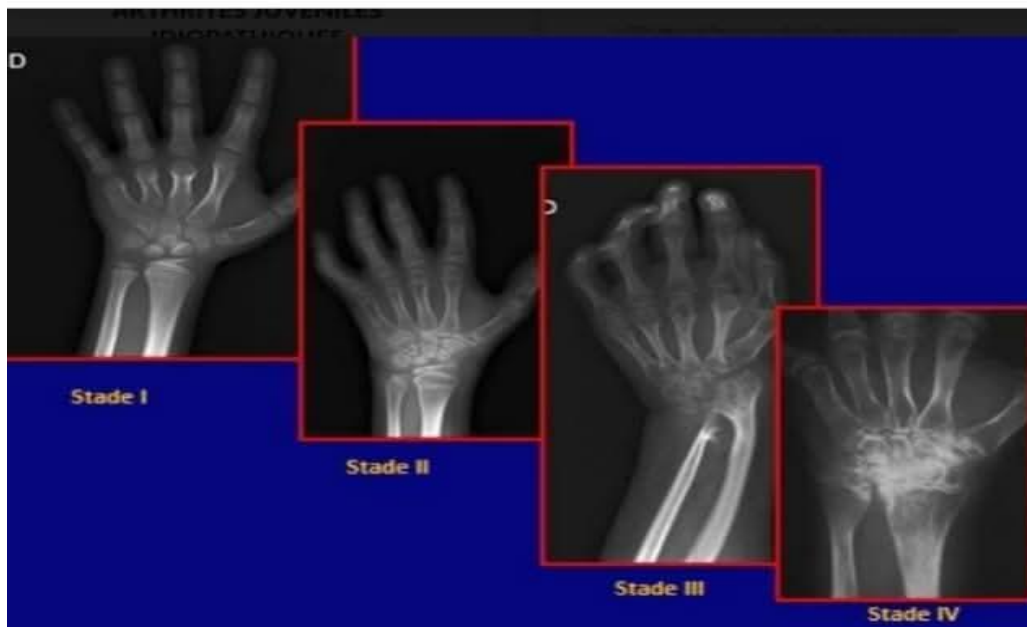
✓ Traitement :

- AINS
- CTC : Prednisone 1_2mg/kg voir 3mg/kg/j VO
- Traitement local par inj intra articulaire sous anesthésie
- Méthotrexate 0.5mg/kg/sem VO ou Sc
- Acide folique 5mg/sem 24_48h après prise de Méthotrexate
- Biothérapie si échec de Méthotrexate
- Rééducation

PARA CLINIQUE BILAN RADIOLOGIQUE

Stades de STEINBROCKER

- **Stade I:** **Gonflement des parties molles**, ostéopénie ,
appositions périostées
- **Stade II:** stade I + **pincement artriculaire**
- **Stade III:** stade II + **érosions osseuses** sous chondrales
- **Stade IV :** stade III + fusion (**ankylose articulaire**)



Balanite

● Clinique :

Inflammation du gland du pénis, souvent d'origine infectieuse, manque d'hygiène..

✓ CAT :

- Bonne hygiène avec de l'eau et savon

Dakin

- Fucidine pmd

- Si gravité : ATB

- ECBU

- Circoncision le plutôt possible

Bronchiolite

● Clinique :

Dyspnée expiratoire, toux asmathéforme, râles sibilants, sifflement, fièvre, vomissements..

- <2ans : 1^{ère} épisode=> Bronchiolite
- 2^{ème} épisode => crise d'asthme
- >2ans=> début d'asthme

✓ CAT :

- 1 Séance de Nébulisation : 20min

Salbutamol 0.03mg/kg + 3cc SSI

- Si amélioration => Traitement de sortie

- Si pas de réponse : 2^{ème} séance de Nébulisation

- Si pas de réponse : 3^{ème} séance de Nébulisation + CTC

Celestene gtt 10gtt/kg

Ou Solumedrol 1mg/kg en IM sans dépasser 40mg

Ou HHC 5mg/kg Max 200mg en IM

Ou Dexa 0.6 mg

■ Si 3 séances et non réponse, bronchiolite sévère, cardiopathie, malnutrition..

→ Hospitalisation

■ Si TLT anormal :

→ Avis pédiatrie

■ Bilan : 

■ FNS/Gly

■ Urée/Créat

■ TP/CU

■ Ionogramme

- TLT si sévère ou 1^{ère} épisode
- ECBU

- Constantes vitales chaque 2h : FR/FC/SaO₂
- Diurèse/24h
- O₂ thérapie
- Arrêt de l'alimentation orale au (-) 24h
- Aspiration/4h
- Séance de Nébulisation/6h

- Si fièvre : ATB
- Claforan 100mg/kg/j chaque 6h en IVD
- CTC : HHC 5mg/kg/6h matin à jeûne
- Réhydratation

✓ Traitement de sortie :

- Bonne hydratation+++
- Fractionner les tétés
- Désobstruction nasale au SSI/2h
- Paracétamol : 15mg/kg 4/j
- Antitussifs déconseillés

- Si aggravation (détresse respiratoire) :
- Hospitalisation
- O2 + Ration de base

1 Lavage nasal au SSI/2h

2 Celestene gtt 10gtt/kg/j le matin pdt 5j

3 Paracétamol si fièvre

⊖ <3mois : Salbutamol est CI, Nébulisation avec du SSI uniquement (Absence des récepteurs au Salbutamol)

Déshydratation aigue

● Clinique :

Pli cutané, yeux cernés, hypotonie, soif, perte du poids, sécheresse des muqueuses :

- Yeux cernés + fontanelle déprimée => 5%
- YC+FD+pli cutané => 8%
- YC+FD+PC+TRC=> 10%
- YC+FD+PC+Fièvre ou soif=> 10%
- YC+FD+PC+ troubles neurologiques=> 15%

Ou $\left[\frac{\text{Poids récent} - \text{Poids now}}{\text{Poids récent}} \right] \times 100 = \dots\%$

■ Bilan : 

■ Gly

■ Urée/Créat

■ Ionogramme sanguin et urinaire.

■ Réhydratation :

✓ 5% : VO=> SRO 50cc/kg en 4h

■ Si réponse libérer le malade

100cc/kg 4h 12h 24h

✓ 5_10% : VO=> SRO 100cc/kg en 4h

+ 4h

■ Si réponse libérer le malade

✓ 10% : VO si possible SRO 100cc/kg en 2h

<2ans : cac 3min

>2ans : dans un verre 3min

■ Si pas possible VO=> IV

■ Si Diarrhées fréquentes/Vomissements
incoercible

TRC >4sec/Troubles neurologiques=>

→ Hospitalisation en IV

● 0_30min : 20cc/kg SSI

30min_2h : 30cc/kg SSI/4.5

Débit = quantité en cc/(temps en
h×3)=....gtt/min

■ Enfant pas uriné : 10cc/kg SSI en 1h renouveler
1fois

Lasilix 1mg/kg en IVD

■ Si malgré Lasilix pas uriné :

→ Avis Réa

■ Au moment où il urine=> on continue

● 2_6h : 50cc/kg SIR ÷ 12 = Débit

■ Tous ces précédents sont les pertes
antérieures

● 6_12h : 50cc/kg SIR ÷ 18 = Débit

■ Pertes en cours

■ Ration de base :

● 12_24h :

0_10kg=> 1000cc/kg/j dans 12h ÷36

10_20kg=> 1000+50cc/kg ÷ 36

>20kg=> 1000+500+20cc/kg ÷ 36

■ Ionogramme :

■ Hyponatrémie si $Na < 120$ => supplémentation

■ Pas uriné : 10cc/kg SSI dans 1h

■ Uriné : continue le schéma

■ Si SIR en manque :

SG5% + 2meq Na/100cc

■ Chaque degré au-delà de 38°C on ajoute
10cc/kg + Perfalgan inj

■ En cas de collapsus (hypoTA) : 20cc SSI/kg en
20min.

- Autres schémas de Réhydratation :

H0_h2 : 10cc/kg/h en absence de collapsus

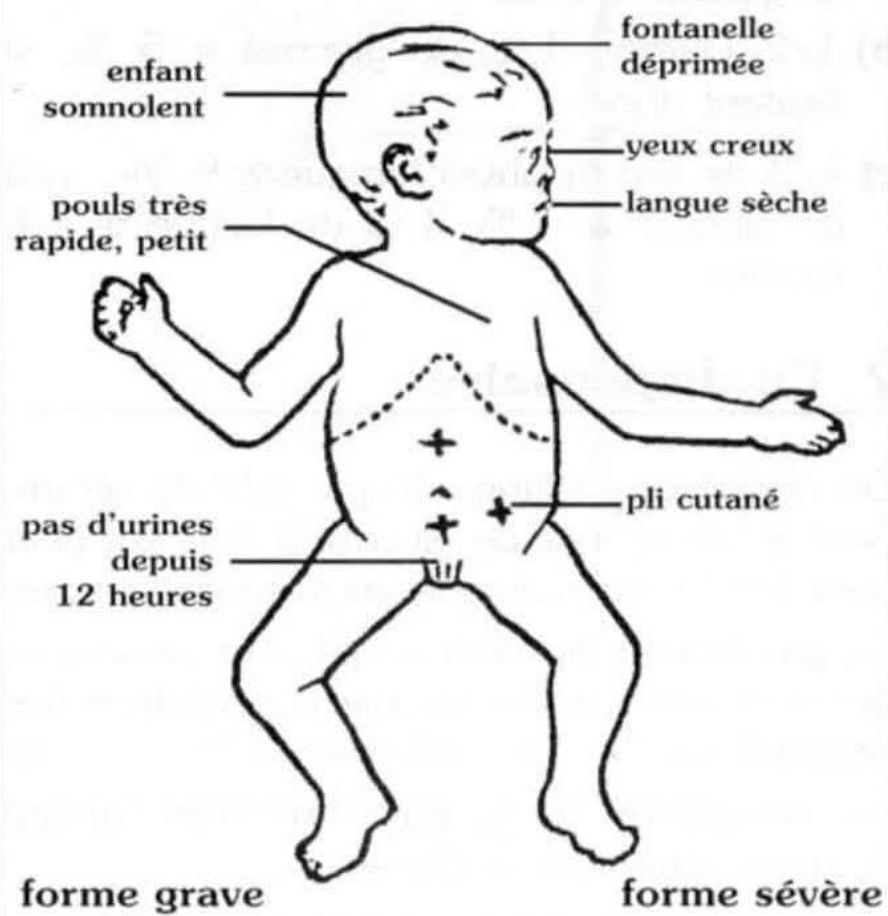
- Si non 20cc/kg en 30min à renouveler jusqu'à correction

H2_h24 : 3l/m²/j

- Supplémentation 4g NaCl + 3g KCl + 1g Gluconate de Ca/l

- Surface corporelle = $(4 \times \text{Poids} + 7) / (90 + \text{Poids})$





Signes de déshydratation

Détresse respiratoire

■ Au moins 2 critères de ces 5 :

■ Cyanose

■ Tirage

■ Geignement respiratoire

■ FR >60/min

■ Battements des ailes du nez

■ Diagnostic (+) : 3 ordres de signes

■ Cyanose

■ Anomalie de FR : Tachycardie ou Polypnée
>60/m

■ Signes d'épuisement : bradypnée, apnée >20s,
pause respiratoire <20s

■ Signes de rétraction

■ Autres signes : bombement d'un hémithorax,
râles humides, souffles cardiaques, infectieux

- TLT

- Gazométrie

- Bilan : 

- FNS/Gly

- Rénal

- Ionogramme/Ca

- Hémostase

- CU

- Diurèse des 24h

- Bactério

- Hypoglycémie : cause ou conséquence de DR

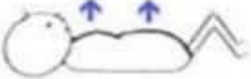
✓ CAT :

- Nébulisation ADS (Adrénaline 1cc + 2cc Dexta + 3cc SSI)
- 2VVP/O2 thérapie
- Libérer les VAS : Position DD
- Sonde gastrique
- Arrêt de l'alimentation orale
- Monitoring et feuille de surveillance
- Nébulisation ADS
- Rechercher et traiter l'étiologie

Classification Détresse Respiratoire

- **DR minime** : Score de Silverman < 4 et FiO_2 : 21%
- **DR modérée** : Score de Silverman [4-6] et FiO_2 : 21% - 40%
- **DR sévère** : Score de Silverman > 6 et FiO_2 > 40%

Evaluation de la fonction respiratoire du nouveau-né
selon le score de SILVERMAN

Paramètres	0	1	2
Balancement thoraco-abdominal à l'inspiration	Absent (respiration synchrone) 	Thorax immobile (abdomen seulement se soulève) 	Respiration paradoxale 
Tirag	absent	intercostal discret	intercostal + sus et sous sternal
Entonnoir xyphoïdien	absent	modéré	intense
Battement des ailes du nez	absent	modéré	intense
Gégnement expiratoire	absent	perçu au stéthoscope	audible continu

Enurésie

● Clinique :

Survenue pendant le sommeil de mictions involontaires et inconscientes chez l'enfant de >5ans ou l'adulte..

■ Bilan : 

■ Gly à jeûne

■ Urée/Créat

■ Ionogramme

■ CU si (+)=> ECBU

■ Échographie AP

 Pédiatre : Desmopressine 60mg/j à partir de 6ans

↗ progressive/semaine

■ Si RAS :  Avis psychologie

Fièvre

- <2ans=> risque de Convulsion

- But : $\rightarrow 39^{\circ}\text{C}$

- ☒ CAT :

- Paracétamol suppo dose de charge 25mg/kg

- Moyens physiques (poche de glace)

- Si pas de réponse : 12.5mg/kg après 1_2h

- Si pas de réponse : Perfalgan ($1.5 \times \text{poids} = ?\text{cc}$)
en IVL

- Si toujours $T^{\circ} > 39^{\circ}\text{C} \Rightarrow$ Bilan pré op

- >30kg=> Paracétamol 15mg/kg en IV

- <30kg=> 12,5mg/kg

- Si pas de réponse ☐ Hospitalisation

■ Bilan : 

■ FNS/CRP/VS

■ CU

■ ECBU

■ TLT

■ Si RAS :

 Avis pédiatrie (PL)

Gaz chez les bébés

- Babygaz
 - Débridat
 - Coliprev
 - Colicalm
 - Gaz baby 5gtt/j
 - Stopcolic ou stop col
 - Biogaia 5gtt à la fois/j
 - Lactazia gtt ou Caspa
 - Caspa gtt : 1mois 1gtt 2mois 2gtt.. 3/j
-
- Massage à l'huile d'olive
 - Mouvements rotatoires des cuisses
 - Flexing des cuisses sur le ventre

Hydrocèle

● Clinique :

Epanchement de liquide aqueux entre les deux feuillets de la tunique vaginale, qui enveloppe le testicule, gonfle le scrotum mais le testicule reste normal. C'est la gêne due au volume de la bourse, qui peut parfois être très important

- Échographie inguino scrotale
- Echodoppler
- Bilan général

☐ → Avis CCI

- Si pas de gêne ni douleur => surveillance
- Si douleur ou gêne => chirurgie
- Hydroceléctomie ou dérivation s'impose

Hypoglycémie

- Si conscient :

- Dextro

- 5g du sucre pour 20kg sans dépasser 3 morceaux qq le poids

Ou une boîte de jus 200ml

- 15min puis donner du sucre lent

- Dextro 15_30min après

- Si inconscient ou avec des crises convulsives :

- Rien par VO

- SG10% : 10ml/kg bolus

- Puis 5ml/kg pour maintenir

- Glucagon en IM :

- >25kg : 1 amp 1mg

- <25kg : 1/2 amp 0.5mg

- Si pas de réponse : inj SG

- SG10% : 2_4cc/kg en IVD

- SG30% : à Éviter le max, 0.5_1cc/kg en IVD

- Arrêt l'inj dès la reprise du conscience

- 15min => sucre lent

- Dextro 15_30min après

- Adapter la dose de l'insuline :

- Présence de cause : pas d'adaptation

- Absence de cause : ➤ la dose d'insuline :

<5U : 0.5U

5_15U : 1U

>15U : 2U

⊖ Glucagon est déconseillé chez le diabétique
sous sulfamides

- Bilan : 
- Glycémie à jeûne
- HBA1C
- Insulinémie
- ACTH
- Cortisol à 8h
- CU
- ECBU

● Hypoglycémie chez un nouveau-né (âge <72h)

■ Gly : < 0.45 g/dl (généralement transitoire)

✓ CAT :

■ Allaitement le plus tôt possible

■ Administration de SG 10% en IV 5ml/kg

■ Voie orale déconseillé voir contre indiquée

■ Si l'hypoglycémie persiste ou la voie IV impossible :

■ Administration du SG par Sonde nasogastrique

Ou

■ Injection du Glucagon ¼ de l'Amp en IM

Ictère néonatale

● Clinique :

Coloration jaune de la peau et/ou des yeux, provoquée par une augmentation du taux de bilirubine dans le sang, somnolence, mauvaise alimentation..

- Précoce: <24h
- Tardif: >7j
- Persistant: >14j
- Grave: taux >200mg/l
- Ictère visible: >40mg/l
- Ictère physiologique: 24_48h de vie
=> disparaît spontanément en 1_2sem
- Ictère pathologique: <24h Bilirubine > seuils normographiques ou signes cliniques graves

→ Photothérapie

- BI > 150mg/l
- BD > 20mg/l
- Si BI > 180mg/l => Exanguinotransfusion
(> 340umol/l ou 20mg/dl ou signes neurologiques)
- Nucléaire : grave due à un taux de bilirubine >200mg

- Causes d'ictère physiologiques:
- Au lait maternel bénigne mais n'arrête pas l'allaitement
- Anémie hémolytique congénitale par Iso RH mère (-) et nn (+)
- Immaturité du système hépatique
- Infection néonatale à E_choli
- Hypothyroïdie congénitale

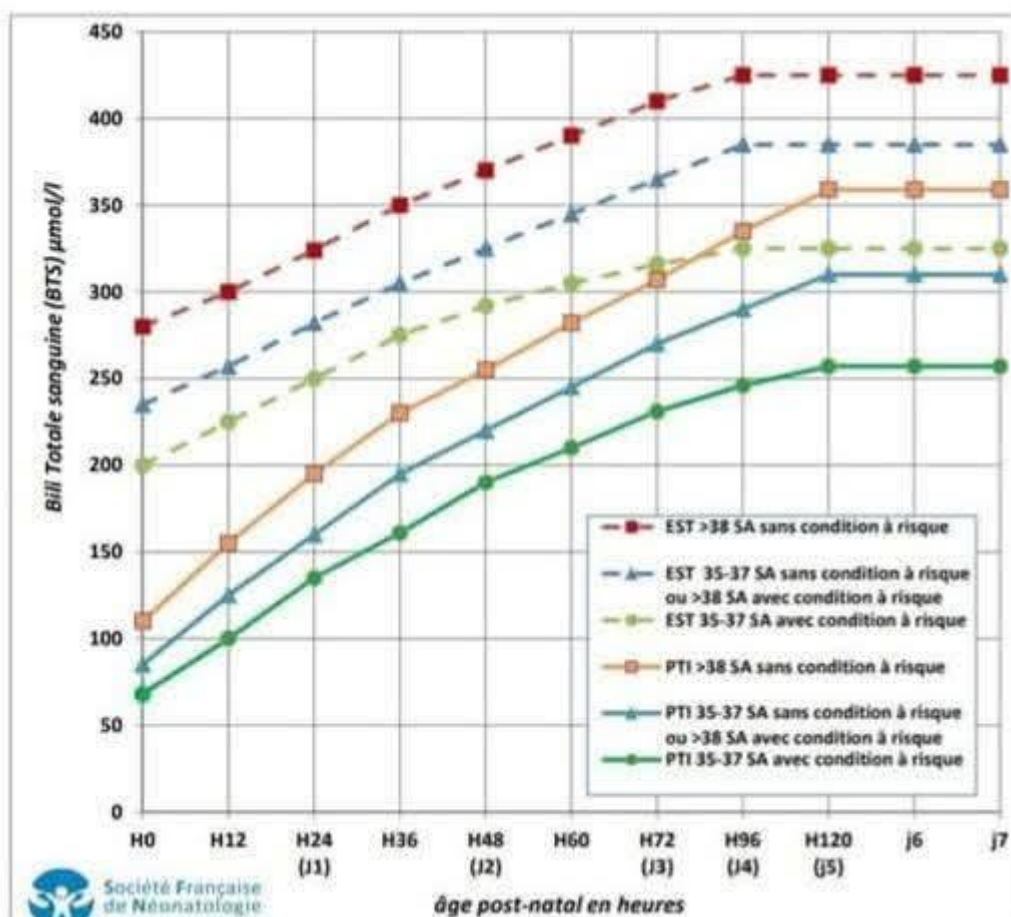
- Bilan: 
- FNS/CRP
- Groupage
- Bilirubine total et conjugué BT/BD
- TSH
- CU

■ Si BD représente plus de 20% de la BT 

Ictère Choléstatique

 Traitement :

- Abstention et contrôle 48h
- Photothérapie pdt 2_3h
- Phénobarbital



Maladie de Kawasaki

● Clinique :

Syndrome lympho_cutanéomuqueux, maladie infantile <5ans, d'origine immunologique, consistant en une vascularite fébrile touchant les artères de moyen et petit calibre.

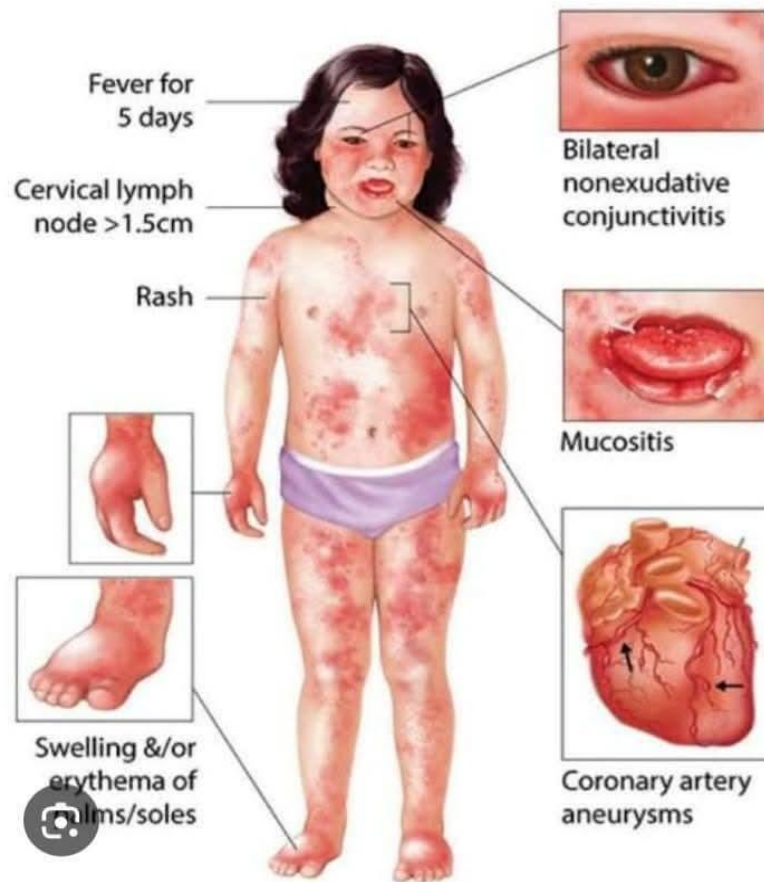
- Yeux rouges sans écoulement
- Lèvres rouges, langue framboisée
- Gonflement, rougeur, desquamation des mains et pieds
- Éruptions cutanées sous forme de taches rouges sur le tronc
- Fièvre pdt 5j rebelle au traitement
- ADP cervicales

✓ Traitement :

- Forte dose d'Ig en IV dose unique 2g/kg en 10_12h
- Aspirine forte dose 20_25mg/kg per os 4/j

→ Avis cardiologie : risque d'anévrismes cardiaques

Kawasaki disease



Laryngite

● Clinique :

Dyspnée inspiratoire, râles sibilants, toux, fièvre, voix rauque, tirage, cornage, battements des ailes du nez, cyanose, stridor inspiratoire, tachypnée..

⊖ Abaisse langue et le décubitus dorsal sont CI risque d'épiglottite

✓ CAT :

● Laryngite sous glottique : 1_3ans

■ Forme grave : Détresse respiratoire++

→ Hospitalisation

■ Dexa 0.5mg/kg en IV ou IM max 12mg

Ou Prednisone (Solumedrol) 1_2mg/kg en IV ou IM

Si persistance renouveler inj

■Nébulisation Adrénaline 1cc Dexta 2cc dans 3cc SSI 20min (jusqu'à 3 séance)

Aérosol d'Adrénaline : 5mg/10ml NaCl 9%
15min

■Si réponse => Traitement de sortie

✓ Traitement de sortie :

1 CTC per os pdt 5j le matin :

<10Kg=> Celestene 10gtt/kg max 400gtt

>10Kg=> Solupred cp 5mg 1mg/kg/j max : 40mg

Predo sirop : poids/3= ?ml 1/j

ATB si : Laryngite sévère ou fébrile

2 Augmentin sirop 1ddp 2/j pdt 7j 80mg/kg/j

3 Paracétamol

4 AH : Tifen ou Deslor sirop. Si NRS : Primalan

5 SSI

- Stade 1 : Traitement ambulatoire par une CTC
- Stade 2 : Dexa 0.6mg/kg en IM
- Stade 3 : Adrénaline 0.1cc/kg sans dépasser 5cc + Dexa en IV + ATB en IV

● Laryngite sus glottique : Grave

Fébrile, teint grisâtre, bouche ouverte, dyspnée brutale sévère => risque de collapsus

→ Réa pédiatrique

PNA

● Clinique :

- Inflammation transitoire du rein et de l'uretère, essentiellement d'origine bactérienne.
- Fièvre, frissons, sueurs, signes fonctionnels urinaires, douleur lomboabdominale, troubles digestifs, AEG
- Signes de gravité : sepsis, Déshydratation
- Signe de Giordano(+)

- Bilan : 
- CU (leucocytes/sang/nitrites)=> ECBU
- FNS/CRP(+)/VS↗
- Hémoculture si gravité.
- Échographie

 Hospitalisation si :

- <3mois
- Sepsis sévère (fièvre mal tolérée, déshydratation, troubles hémodynamiques)
- Uropathies, lithiase urinaire
- Immunodépression

 Traitement :

- Ceftriaxone 50mg/kg/j 1inj/j

Ou Claforan 100_150mg/kg/j 4inj/j en IVD

- Ou Ambulatoire :

Cefixime 4mg/kg/12h en PO pdt 10j

Puis adapter selon AntibioGramme

- Contrôle : ECBU

Poussée dentaire

● Clinique :

- Salives+++ a tendance à mordiller, irritable et pleure facilement, joues rouges, mange et dort moins bien que d'habitude, gencives un peu gonflées, fièvre, diarrhées, douleur abdominale..
- A partir de 6mois_16mois, dure 8j.

✓ Traitement :

- Dologel 1app 2/j
- Dolodent sol 1app 3/j

Ration de base

● La RB fait référence à la quantité de liquides et d'électrolytes nécessaire pour couvrir les besoins quotidiens d'entretien chez un enfant en bonne santé, dans des conditions normales (sans pertes excessives, comme diarrhée ou vomissements).

Elle permet de maintenir une hydratation adéquate et de compenser les pertes insensibles (via la respiration, la sueur..) ainsi que les pertes normales via les urines et les selles

- Intérêt de la ration de base :
- Maintien de l'homéostasie hydrique et électrolytique.
- Prévention de la déshydratation ou de l'excès de liquides.
- Apport d'énergie dans certains cas via le glucose (utilisé en perfusion intraveineuse).

✓ Sérum glucosé:

■ 0_10kg: 100cc/kg/j

(10% <3mois/5% >3mois)

■ 10_20kg: 50cc/kg/j

■ >20kg: 20cc/kg/j

■ Exemple: Poids=17kg

■ $10 \times 100\text{cc/kg/j SG5\%} = 1000\text{cc/j}$

■ $7 \times 50\text{cc/kg/j SG5\%} = 350\text{cc/j}$

■ 1350cc/j: Cette quantité sera divisée en 3
flacons de même volume

■ Soit $3 \times 450\text{cc SG5\%}$

✓ Les électrolytes:

■ NaCl: $(2 \times P)/1.7$ ou 2_3mmol/kg/j

■ KCl: $(2 \times P)/1.3$ ou 1_2mmol/kg/j

■ CaCl₂: P/2

Ou

- Pour les 1ères 10kg: 100ml/kg/j
- Les 10kg suivants (10_20kg): 50ml/kg/j
- Pour chaque kg au-delà de 20kg: 20ml/kg/j

■ Exemple de calcul :

■ 8kg : $8\text{kg} \times 100\text{ml} = 800\text{ml/j}$

■ 15kg: les 1ères 10kg: $10\text{kg} \times 100\text{ml} = 1000\text{ml}$

Pour les 5kg restants: $5\text{kg} \times 50\text{ml} = 250\text{ml}$

Total: $1000\text{ml} + 250\text{ml} = 1250\text{ml/j}$

■ 25kg: Pour les 1ères 10kg: $10\text{kg} \times 100\text{ml} = 1000\text{ml}$

Les 10kg suivants : $10\text{kg} \times 50\text{ml} = 500\text{ml}$

Les 5kg restants : $5\text{kg} \times 20\text{ml} = 100\text{ml}$

Total: $1000\text{ml} + 500\text{ml} + 100\text{ml} = 1600\text{ml/j}$

Retard de croissance

- Radio du poignet gauche
- Sérologie de maladie cœliaque: IgA totaux
- Protides totaux, Albuminémie
- FNS/Glycémie à jeun
- Fer sérique
- Ionogramme/Ca
- Phosphorémie
- Dosage de GH
- Albuminémie
- TP/TGO/TGP
- ASAT/ALAT
- CT/TG/LDL/HDL
- Urée/Créat

- TSH/T4
- PTH
- Ac anti transglutaminase

Rougeole

● Clinique :

- Fièvre, AEG, catarrhe oculo laryngo nasal : larmoient, œil rouge, rhinorrhée, toux
- Signe de Koplick : petits points blanchâtres bleutés « en grain de semoule » sur fond érythémateux, inconstant et fugace au nv de muqueuse jugale.
- Éruption maculopapuleuses
- Xanthème morbiliforme débute derrière les oreilles avec intervalle de peau saine.
- Déclaration obligatoire
- Éviction 5j

✓ Traitement symptomatique :

- Antihistaminique
- Chlorhexidine/Eosine aqueuse 1 app 2/j
- Paracétamol

Rubéole

● Clinique :

- BEG, fièvre, courbatures, myalgies, arthralgies, rhinorrhée, toux, conjonctivite, ADP
 - Exanthèmes maculo papuleux, début au visage pas cuir chevelu, tronc, membres supérieurs puis inférieur, pas prurit
 - Respecte la région palmoplantaire
 - Exanthème maculopapuleux rose au nv de la face puis thorax sans atteinte de cuir chevelu
-
- Bilan : 
 - FNS=> Leucopénie/Sd mononucléose :
Hyperlymphocytose
 - PCR
 - Sérologie

✓ Traitement :

- Repos
- Symptomatique : Antipyrétique
- Éviter le contact avec la femme enceinte 🚫

Sortie de nouveau_né

● Examen clinique :

- Examen des yeux
- Reflexes archaïques
- Dépistage des luxations de l'épaule et de hanche
- Vomissement+++ (atrésie de l'œsophage)
- Émission de méconium
- Fontanelle
- Ictère +++
- Omphalite

1 Eosine aqueuse lotion 1 app 2/j

2 Compresses stériles/Bondage ombilical

3 Madecassol après chute de cordon

4 Rifamycine coll 1gtt/œil 2/j

Ou Azyter coll 1gtt 2/j pdt 5j

Ou Tobrex coll 1gtt 2/j pdt 5j

■ Si prématuré : Supplémentation en Fer, Vit D et Ca

Supplémentation en vitamine D

- En cas de déficit :
 - 50.000Ui/sem pdt 6_8sem (capsule molle ou solution buvable)
 - Refaire le dosage après 8sem
 - Pour prévenir des rechutes: dose d'entretien 50.000UI/mois
- Exposition au soleil/Alimentation

Que faire en cas de déficit / insuffisance en vitamine D ?

Poids de l'enfant	Taux de 25OH vitamine D	Dose colécalciférol
< 20 kg	< 30 ng/ml (< 75 nmol/L)	100 000 UI
	< 10ng/ml (< 25 nmol/L)	100 000 UI par mois pendant 2 mois (200 000 UI au total)
20 – 60 kg	10 – 20 ng/ml (25 – 50 nmol/L)	100 000 UI toutes les 6 semaines pendant 2 mois (200 000 UI au total)
	20 – 30 ng/ml (50 – 75 nmol/L)	100 000 UI
	< 10 ng/ml (< 25 nmol/L)	100 000 UI toutes les 2 semaines pendant 2 mois (400 000 UI au total)
> 60 kg	10 – 20 ng/ml (25 – 50 nmol/L)	100 000 UI toutes les 2 semaines pendant 6 semaines (300 000 UI au total)
	20 – 30 ng/ml (50 – 75 nmol/L)	100 000 UI toutes les 2 semaines pendant 4 semaines (200 000 UI au total)
	< 10 ng/ml (< 25 nmol/L)	100 000 UI toutes les 2 semaines pendant 4 semaines (200 000 UI au total)

Aurelle et al. European Journal of Pediatrics (2020)

■ A la naissance :

Dose : 100.000ui donc 1/2amp de 200.000ui

☒ 1mois

☒ 6mois

☒ 12mois

☒ 18mois

☒ 24mois

Puis chaque année (janvier) jusqu'à 14ans

Syndrome de Tourniquet

● Clinique:

La constriction bloque d'abord le retour veineux puis le flux lymphatique et si elle persiste, elle interrompt la circulation artérielle=> risque d'ischémie et de nécrose

Œdème distal, rougeur, cyanose, marque circulaire profonde, sillon, douleur intense et agitation chez le bébé

✓ CAT:

- Retrait immédiat du cheveu/fil avec loupe
- Parfois section au bistouri ou aiguille stérile en milieu médical
- Évaluation de la viabilité du segment atteint



Syndrome de main pieds bouche

● Clinique : <5ans

Infection virale bénigne

Fièvre, maux de tête, mal de gorge, perte d'appétit, écoulement nasal, diarrhée, vomissements +/- toux.

Boutons rouges au niveau de bouche avec des petites bulles douloureuses

Vésicules au niveau de paume des mains, plantes des pieds et sur les fesses

Petites vésicules sur toutes les régions du corps

✓ Traitement : symptomatique

1 Bain de bouche avec Bicarbonates 1cac dans un verre d'eau 2_3/j.

2 Antipyrétique si fièvre

3 Antihistaminique

4 Eosine aqueuse pour les lésions 1app/j



Viroses

Rubéole/Rougeole/Varicelle

- 1 Histagan sirop 1cam 2/j
- 2 Chlorhexidine/Eosine aqueuse 1app 3/j
- 3 Paracétamol

■ Surinfection :

- 1 Keforal sirop 1ddp 3/j
- 2 Zeta crème 1app 2/j
- 3 Chlorhexidine/Eosine aqueuse 1app 3/j